Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Установка вентиляционной трубки / миринготомия

Установка вентиляционных трубок (шунтов) в барабанную перепонку / вскрытие барабанной перепонки для удаления жидкости

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Сторона: ☐ Правая ☐ Левая ☐ Обе

Планируемая процедура:
☐ Миринготомия + вентиляционная трубка
☐ Только миринготомия (без трубки)

Тип трубки:
☐ Трубка для краткосрочного стояния (шунт)
☐ Трубка для длительного стояния (Т-образная и др.) _____

Дополнительные процедуры в ту же сессию: ☐ Аденоидэктомия ☐ Тонзиллэктомия ☐ Нет _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Среднее ухо — это небольшая полость за барабанной перепонкой, которая в норме заполнена воздухом. Она вентилируется через **слуховую (евстахиеву) трубу**, которая открывается в заднюю часть носа. Когда слуховая труба работает плохо (особенно у детей — из-за увеличенных аденоидов, аллергии или частых простуд), в среднем ухе **скапливается жидкость** (экссудативный средний отит).

Эта жидкость может вызывать **снижение слуха**, а у детей — **задержку развития речи и языковых навыков**, проблемы с вниманием, нарушение равновесия и **повторяющиеся воспаления уха**. Если жидкость сохраняется длительное время, барабанная перепонка может истончиться, втянуться и стойко измениться. Похожие проблемы могут возникать и у взрослых, например после перелётов или погружений под воду, а также из-за заболеваний в задней части носа.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Цель этой процедуры — сделать небольшое отверстие в барабанной перепонке, чтобы удалить жидкость, и с помощью установленной в нём маленькой трубки обеспечить вентиляцию среднего уха — **улучшить слух и уменьшить частоту воспалений.**

2 Как выполняется процедура?

У детей процедуру обычно проводят под кратковременной общей анестезией; у взрослых — чаще всего под местной анестезией. Её выполняют через наружный слуховой проход под микроскопом; **снаружи нет никаких разрезов или рубцов.**

1. **Очищение слухового прохода:** Под микроскопом из слухового прохода удаляют серу и осматривают барабанную перепонку.
2. **Миринготомия:** В той части барабанной перепонки, где это не повлияет на слух, делают небольшой надрез длиной около 1–2 мм.
3. **Удаление жидкости:** Жидкость из среднего уха (она может быть прозрачной, вязкой или гнойной) удаляют тонким отсосом. При необходимости можно взять образец для посева.
4. **Установка трубки:** В отверстие устанавливают крошечную трубку в форме катушки размером в несколько миллиметров. Эта трубка временно берёт на себя функцию слуховой трубы и обеспечивает вентиляцию среднего уха.
5. **Завершение:** При необходимости закапывают ушные капли. Обычно в ухо ничего не вводят или кладут лишь небольшой кусочек ваты.

Трубки для краткосрочного стояния обычно выталкиваются естественным образом в течение **6–18 месяцев** по мере заживления барабанной перепонки и выпадают в слуховой проход; часто это происходит незаметно. **Трубки для длительного стояния** остаются на месте дольше, и иногда их приходится удалять в ходе отдельной процедуры.

Если выполняется только миринготомия (без трубки), отверстие в барабанной перепонке закрывается в течение нескольких дней, и жидкость может скопиться снова.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Детям — общая анестезия; взрослым — обычно местная анестезия	Около 10–20 минут на оба уха	Обычно выписка домой в тот же день

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Слух обычно улучшается сразу или в течение короткого времени
- У детей — положительное влияние на речь, развитие языковых навыков, внимание и успеваемость в школе
- Воспаления уха возникают реже и протекают легче; если воспаление всё же возникает, его обычно можно лечить ушными каплями вместо антибиотиков внутрь
- Ниже риск стойкого повреждения барабанной перепонки; проходит ощущение давления и заложенности в ухе

Пока трубка находится на месте и проходима, у подавляющего большинства пациентов слух улучшается, а воспаления уха возникают реже. Если к моменту выпадения трубки слуховая труба достаточно созрела, жидкость обычно больше не скапливается. Однако у некоторых детей (примерно у **20–30 из 100**) жидкость скапливается снова, и может потребоваться **повторная установка трубок**.

4 Другие варианты лечения

- **Наблюдение:** У многих детей жидкость в среднем ухе проходит сама по себе в течение 3 месяцев. Если снижение слуха лёгкое и нет факторов риска, возможно наблюдение с регулярными исследованиями слуха.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Аутоинфляция:** Особенно у детей постарше надувание носом специального воздушного шарика может помочь открыть слуховую трубу.
- **Слуховые аппараты:** Для пациентов, которые не хотят операции или которым она не подходит, они могут стать временным решением, пока сохраняется жидкость.
- **Лекарства:** При наличии аллергии или заболеваний носа и пазух проводится их лечение; однако доказательства того, что антибиотики, кортикостероиды или назальные спреи надолго устраняют жидкость в среднем ухе, ограничены.
- **Аденоидэктомия:** Подходящим детям она может быть рекомендована вместе с установкой трубок или когда требуется повторная установка трубок.

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Без процедуры у некоторых пациентов жидкость может пройти сама; однако если она сохраняется, могут продолжаться снижение слуха, у детей — задержка развития речи и языковых навыков, проблемы с вниманием и учёбой, нарушение равновесия и повторяющиеся воспаления уха. Длительно сохраняющаяся жидкость может приводить к втяжению барабанной перепонки (ретракции), стойким изменениям перепонки, повреждению слуховых косточек и, в редких случаях, к более серьёзным заболеваниям уха, требующим операции, таким как **холестеатома**.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед процедурой проводятся исследование слуха (аудиометрия) и исследование давления в среднем ухе (тимпанометрия).
- Если планируется общая анестезия, вас осмотрит врач-анестезиолог; в течение **6 часов** до операции нельзя давать твёрдую пищу и молоко, а в отношении прозрачных жидкостей соблюдайте время, указанное анестезиологом.
- Пожалуйста, сообщите нам, если в течение 2 недель до процедуры была повышенная температура, кашель или грипп; процедура может быть отложена.
- Если из уха есть выделения или имеется активное воспаление, перед процедурой может потребоваться их лечение.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин E, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

День процедуры	Большинство пациентов уходят домой через несколько часов. Возможны небольшая боль в ухе или ощущение заложенности, которые проходят после приёма простых обезболивающих. В течение нескольких дней из уха могут быть небольшие выделения

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	с примесью крови или водянистые выделения. Большинство пациентов **сразу начинают слышать звуки громче**; поначалу это может ощущаться неприятно.
Первая неделя	Если врач рекомендовал, используются ушные капли. Дети могут вернуться в школу или детский сад, а взрослые — на работу в течение 1–2 дней. Следите за тем, чтобы в уши не попадала вода.
4–8-я недели	Проводится первый контрольный осмотр; мы проверяем, что трубка на месте и проходима, и повторяем исследование слуха.
Пока трубка стоит (6–18 месяцев)	Рекомендуются осмотры примерно **каждые 3–6 месяцев**. Воспаление уха проявляется выделениями и обычно лечится ушными каплями. Перелёты, как правило, переносятся легче, пока трубка стоит.
После выпадения трубки	Барабанную перепонку осматривают, чтобы убедиться, что отверстие закрылось и в среднем ухе нет жидкости; проводится исследование слуха.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Небольшая боль в ухе и ощущение заложенности (1–2 дня)
- Небольшие выделения из уха с примесью крови или водянистые выделения в течение нескольких дней
- Временное ощущение, что звуки очень громкие или отдаются эхом
- Временная тошнота или беспокойство после общей анестезии

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Выделения из уха (оторея)** — Примерно у **10–25 из 100** пациентов с трубками бывает хотя бы один эпизод выделений из уха, обычно после простуды или попадания воды в ухо. Чаще всего выделения проходят в течение нескольких дней при использовании ушных капель с антибиотиком. В редких случаях выделения могут быть стойкими и потребовать приёма лекарств внутрь, очищения уха или удаления трубки.
- **Белые пятна на барабанной перепонке (тимпаносклероз)** — Белые, похожие на мел пятна на барабанной перепонке встречаются часто (примерно в **10–30+ из 100** ушей). В большинстве случаев они не влияют на слух.
- **Раннее выпадение или закупорка трубки** — Трубка может выпасть раньше, чем ожидалось, или закупориться засохшей кровью или выделениями. В этом случае пытаются восстановить её проходимость с помощью капель; при необходимости трубку заменяют.
- **Необходимость повторной установки трубок** — Если после выпадения трубки жидкость скапливается снова, примерно **20–30 из 100** детей может потребоваться повторная установка трубок (иногда вместе с удалением аденоидов).

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Нечастые состояния

- **Стойкое отверстие в барабанной перепонке (перфорация)** — После выпадения трубки отверстие в барабанной перепонке может не закрыться: примерно у **1–3 из 100** пациентов с трубками для краткосрочного стояния и чаще при трубках для длительного стояния (примерно у **10–20 из 100**). Небольшие отверстия часто не вызывают проблем; если они приводят к повторяющимся выделениям или снижению слуха, может потребоваться **закрытие отверстия в ходе отдельной операции (тимпанопластики/миринготомии)**.
- **Истончение или втяжение барабанной перепонки** — В месте, где стояла трубка, барабанная перепонка может истончиться или втянуться внутрь; может потребоваться наблюдение.
- **Трубка не выпадает** — Если трубка не выпадает в ожидаемый срок (обычно если она остаётся дольше 2–3 лет), может потребоваться её удаление в ходе короткой процедуры; у детей это обычно делают под общей анестезией.
- **Разрастание ткани в слуховом проходе (грануляции)** — Вокруг трубки может образоваться красная воспалённая ткань; она может вызывать выделения с примесью крови и лечится каплями или небольшой процедурой.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Смещение трубки в среднее ухо** — Очень редко вместо того, чтобы выпасть наружу, трубка может сместиться за барабанную перепонку в среднее ухо; для её удаления может потребоваться отдельная процедура.
- **Холестеатома** — Кистоподобное заболевание, возникающее из-за врастания кожного слоя барабанной перепонки в среднее ухо. С установкой трубки оно связано **очень редко**. Если оно развивается, требуется хирургическое лечение.
- **Снижение слуха, звон в ухе (тиннитус) или головокружение** — Стойкое снижение слуха, шум в ушах или головокружение из-за поражения внутреннего уха или слуховых косточек встречаются **крайне редко**.
- **Травма слухового прохода и кровотечение** — В узких слуховых проходах возможны небольшие травмы; очень редко сообщалось о серьёзных повреждениях, связанных с анатомическими особенностями лицевого нерва, внутреннего уха или крупных кровеносных сосудов.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- Обильные выделения из уха или выделения с неприятным запахом, которые сохраняются **более 3–5 дней**, несмотря на капли
- **Температура выше 38,5 °C**, сильная боль в ухе
- Покраснение или отёк за ухом либо оттопыривание ушной раковины вперёд
- **Внезапное снижение слуха**, сильное головокружение, неустойчивость или рвота
- Асимметрия лица, опущение угла рта или невозможность закрыть глаз
- Сильное кровотечение из уха

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Пока трубка стоит, **не допускайте попадания в ухо грязной воды (из озера, моря, бассейна, воды из ванны).** В душе и в ванне можно использовать вату, смазанную вазелином, или беруши. Относительно плавания следуйте рекомендациям врача; обычно разрешается плавать на поверхности воды в берушах и/или плавательной шапочке, но нырять не рекомендуется.
- Не очищайте слуховой проход изнутри ватными палочками.
- Если появились выделения из уха, осторожно вытирайте их снаружи, используйте рекомендованные вам капли и сообщите об этом врачу. Не используйте самостоятельно другие ушные капли; некоторые капли не подходят для среднего уха.
- Продолжайте приходить на контрольные осмотры даже после выпадения трубки; важно следить за слухом и состоянием барабанной перепонки.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что через определённое время трубка выпадет сама, что при повторном скоплении жидкости может потребоваться повторная установка трубок и что, если в барабанной перепонке останется стойкое отверстие, для его закрытия может потребоваться отдельная операция.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — степень родства:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТКАЗА)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.